

肺癌:薬剤師の実践ポイント

服薬指導・相互作用・病院との連携のポイント

1 実践チェックリスト(保険薬局/病院)

保険薬局薬剤師

- ☐ 経口TKIの服用時点(エルロチニブは空腹時)・残薬の確認
- ☐ 市販の胃薬・サブリを含めた相互作用の確認
- ☐ 電話フォローで皮疹・下痢・咳・息切れを確認
- ☐ 皮疹・爪囲炎のスキンケア指導と外用薬の使い方
- ☐ 症状をGradeで記録し、トレーシングレポートで病院へ

病院薬剤師

- ☐ ドライバー遺伝子・PD-L1の結果とレジメンの整合性の監査
- ☐ 化学療法の投与量計算、前投薬(葉酸・B12、過敏症予防)の確認
- ☐ ILD・irAE発症時の院内連携(呼吸器・内分泌など)
- ☐ 外来化学療法室・導入時の副作用説明
- ☐ お薬手帳へのレジメン情報・投与日の記載

病院と共有する情報

ドライバ遺伝子・治療ライン

検査値

皮疹・下痢のGrade

咳・息切れの有無

2 主なレジメン・経口薬と薬局での確認ポイント

レジメン・薬剤	構成・投与スケジュール	周期	薬局での確認ポイント
CDDP+PEM	シスプラチン+ペメトレキセド(非扁平上皮)。維持療法はペメトレキセド単剤	3週毎	葉酸・ビタミンB12の前投与、腎機能低下時のNSAIDs併用、大量補液
CBDCA+PTX	カルボプラチン+パクリタキセル(土ペバシズマブ)	3週毎	過敏症予防の前投薬、溶媒のエタノール(運転・飲酒)、末梢神経障害
オシメルチニブ	80mg 1日1回 連日内服	連日	QT延長薬の併用、乾性咳嗽・息切れ(ILD)、爪囲炎
アレクチニブ	300mg 1日2回 連日内服	連日	筋肉痛・CK上昇、便秘、光線過敏(日焼け対策)
ロルラチニブ	100mg 1日1回 連日内服	連日	脂質異常症(定期的な脂質検査)、気分・認知の変化、リファンピシンは併用禁忌
DTX+RAM	ドセタキセル+ラムシルマブ	3週毎	発熱性好中球減少(G-CSF予防の検討)、浮腫、口内炎

3 相互作用・併用注意(他院処方・市販薬・サブリを含む)

重要度	薬剤(機序)	相手の薬(区分)	起こること	薬局での対応
禁忌	ロルラチニブ CYP3A4強誘導	処方薬 リファンピシン(抗結核薬)	重篤な肝障害・効果減弱	併用しない。他院の抗結核薬の処方を確認
注意	ゲフィチニブ・エルロチニブ 胃内pH上昇で吸収低下	処方薬 市販薬 PPI・H2ブロッカー(市販の胃薬も)	血中濃度↓→効果減弱	市販のH2ブロッカーも確認、服用時間を調整
注意	オシメルチニブ・クリゾチニブ等 QT延長の重複	処方薬 抗不整脈薬・マクロライド系等	QT延長・不整脈	併用薬と低K・低Mg血症の有無を確認
注意	EGFR・ALK阻害薬 CYP3A4阻害・誘導	サブリ・食品 グレープフルーツ・セイヨウオトギリソウ	副作用↑・効果↓	食品・サブリの摂取を聴取
注意	ペメトレキセド 腎排泄の低下	処方薬 市販薬 NSAIDs(市販の解熱鎮痛薬も)	骨髄抑制・粘膜障害↑(腎機能低下例)	投与前後の市販鎮痛薬の使用を聴取
確認	ICI 免疫反応の増強	既往・疾患 自己免疫疾患・間質性肺炎患の既往	irAE・既往の増悪	既往歴と他院での治療状況を確認

4 服薬指導の声かけ例と確認のタイミング

治療開始前

「この薬は毎日同じ時間に飲み続けることで効果を保ちます。飲み忘れた時の対応も一緒に確認しましょう」

確認:お薬手帳でドライバ遺伝子・治療ライン、併用薬(胃薬・QT延長薬・CYP3A4関連)
△ ペメトレキセドは葉酸・B12の前投与を開始済みか

TKI開始1~4週

「顔や胸のニキビのような発疹は、保湿と早めの塗り薬で抑えられます。我慢せず教えてください」

確認:電話フォローで皮疹・下痢のGrade、保湿剤・外用薬の使い方

△ 水様便が1日4回以上増える時は連絡

化学療法1~2週

「37.5℃以上の熱が出たら、解熱剤で様子を見ずに、すぐ病院へ連絡してください」

確認:電話フォローでnadir期の発熱・口内炎を確認

△ 発熱・悪寒はFNを疑い夜間休日でも受診

治療中はいつでも

「息切れや空咳が続く時、熱を伴う時は、次の受診を待たずに連絡してください」

確認:来局ごとに咳・息切れ・発熱、ICIでは倦怠感・口渇・動悸を聴取

△ 息切れ・空咳・発熱はILDを疑い至急受診